

L'hyperuricémie asymptomatique, un signal précoce du risque cardiométabolique



A.ZAIDI(1), I.LAIDOUNI(2), R.KARA LAOUER(3).

(1) SERVICE BIOCHIMIE L'hôpital militaire régionale universitaire de Constantine.

Introduction

L'acide urique, produit terminal du catabolisme des purines, est de plus en plus évoqué comme un acteur des perturbations métaboliques. Notre étude transversale, réalisée à l'Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine, inclut 70 patients présentant des composantes du syndrome métabolique afin d'évaluer la fréquence de l'hyperuricémie asymptomatique et ses liens avec les paramètres métaboliques.

Matériels et méthodes

- Type d'étude : Étude transversale.
- Lieu : Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine.
- Population : 70 patients présentant des composantes du syndrome métabolique.
 - Paramètres évalués : Âge et Indice de Masse Corporelle (IMC).
- Uricémie (concentration d'acide urique).
- Bilan lipidique : Cholestérol total, LDL-cholestérol et Triglycérides.

Discussion

Dans notre étude, l'hyperuricémie asymptomatique était associée à l'âge avancé, l'obésité et l'adiposité abdominale. Une association significative a également été retrouvée avec les triglycérides élevés et le HDL-cholestérol bas, ainsi qu'entre l'IMC et les taux de cholestérol total et LDL.

Aucune corrélation significative n'a été retrouvée entre l'uricémie et la glycémie. En revanche, 37 % des patients hyperuricémiques présentaient des complications cardiovasculaires et 66,67 % des patients hypertendus étaient hyperuricémiques.

Ces résultats suggèrent que l'hyperuricémie asymptomatique pourrait être un marqueur du risque métabolique et cardiovasculaire. Les principales limites sont la petite taille de l'échantillon, l'absence de groupe témoin et la courte durée de suivi.

Résultats

Caractéristiques de la population (n = 70)

Paramètres	Valeur moyenne
1. Âge (ans)	58,2 ± 12,5
2. IMC (kg/m ²)	32,6 ± 5,5
3. Acide urique (mg/L)	640 ± 177
4. Bilan lipidique	Cholestérol Total, LDL, Triglycérides

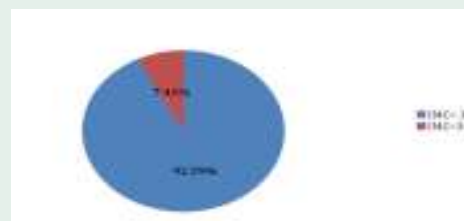


Figure 1. Répartition des patients hyperuricémiques selon l'IMC

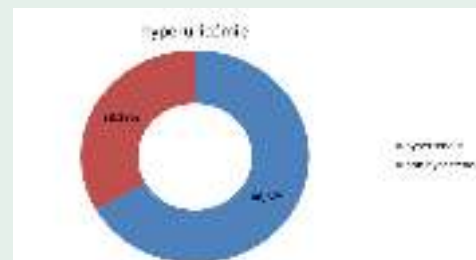


Figure 2. Répartition des patients hyperuricémiques selon l'HTA

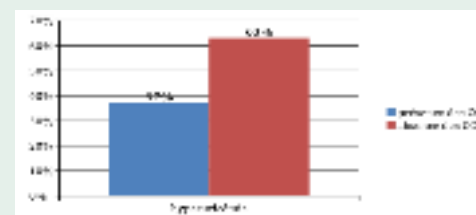


Figure 3 : Répartition des patients hyperuricémiques selon les CCV

Corrélation des paramètres							
Paramètres	Hyperuricémie	IMC	Cholestérol Total	LDL-cholestérol	HDL-cholestérol	Triglycérides	Complications Cardiovasculaires
Hyperuricémie	1,000	0,125	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001
IMC	0,125	1,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Cholestérol Total	0,010	0,001	1,000	0,001	0,001	0,001	0,001
LDL-cholestérol	0,001	0,001	0,001	1,000	0,001	0,001	0,001
HDL-cholestérol	0,001	0,001	0,001	0,001	1,000	0,001	0,001
Triglycérides	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	1,000	0,001
Complications Cardiovasculaires	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	1,000

Tableau : Corrélation des paramètres chez les patients

Conclusion

L'hyperuricémie asymptomatique est associée à l'obésité et aux anomalies lipidiques, notamment aux triglycérides élevés et au HDL bas. Elle pourrait constituer un marqueur du risque métabolique et cardiovasculaire, justifiant un dépistage et un suivi des patients concernés.

Référence

1. Richette P. & Bardin T. Acide urique, hyperuricémie et syndrome métabolique. La Presse Médicale, 2010.
2. Bardas A. & Paquot N. Hyperuricémie asymptomatique : faut-il traiter ? Revue Médicale de Liège, 2017.
3. Haute Autorité de Santé (HAS). Prise en charge de la dyslipidémie et prévention du risque cardiovasculaire, 2021.